Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Sémiologie respiratoire

Etude synthétique (2) Syndromes pulmonaires, bronchiques, médiastinaux

Pr Ouail D. MD, MCB
Service de Médecine Interne
ouailouailbejaia@gmail.com

SYNDROMES PULMONAIRES

Introduction

- Les syndromes de condensation pulmonaire
- Les syndromes cavitaires
- L’emphysème

Les syndromes de condensation pulmonaire

- La condensation pulmonaire est une densification du parenchyme pulmonaire
- Intéressant le plus souvent un lobe qui
- Ressemble macroscopiquement à du parenchyme hépatique d'où le terme d'hépatisation.

Les syndromes de condensation pulmonaire

- Le parenchyme pulmonaire,
  - perd son élasticité
  - ne flotte plus dans l'eau.
- La condensation pulmonaire peut être due :
  - Soit à une infection bactérienne du parenchyme :
    - c'est la pneumonie franche lobaire aiguë.
  - Soit à une embolie artérielle : c'est l'infarctus pulmonaire.

Ces deux premiers types réalisent

un syndrome de condensation pulmonaire non rétractile

Les syndromes de condensation pulmonaire

- La condensation pulmonaire peut être due :
  - Soit à une obstruction bronchique : réalisant l'atélectasie
    - l'absence de ventilation dans le territoire pulmonaire dépendant de la bronche obstruée

un syndrome de condensation pulmonaire rétractile.

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

palpation :

- augmentation des vibrations vocales

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

percussion :

- Matité
- Submatité
- À limites nettes

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

auscultation :

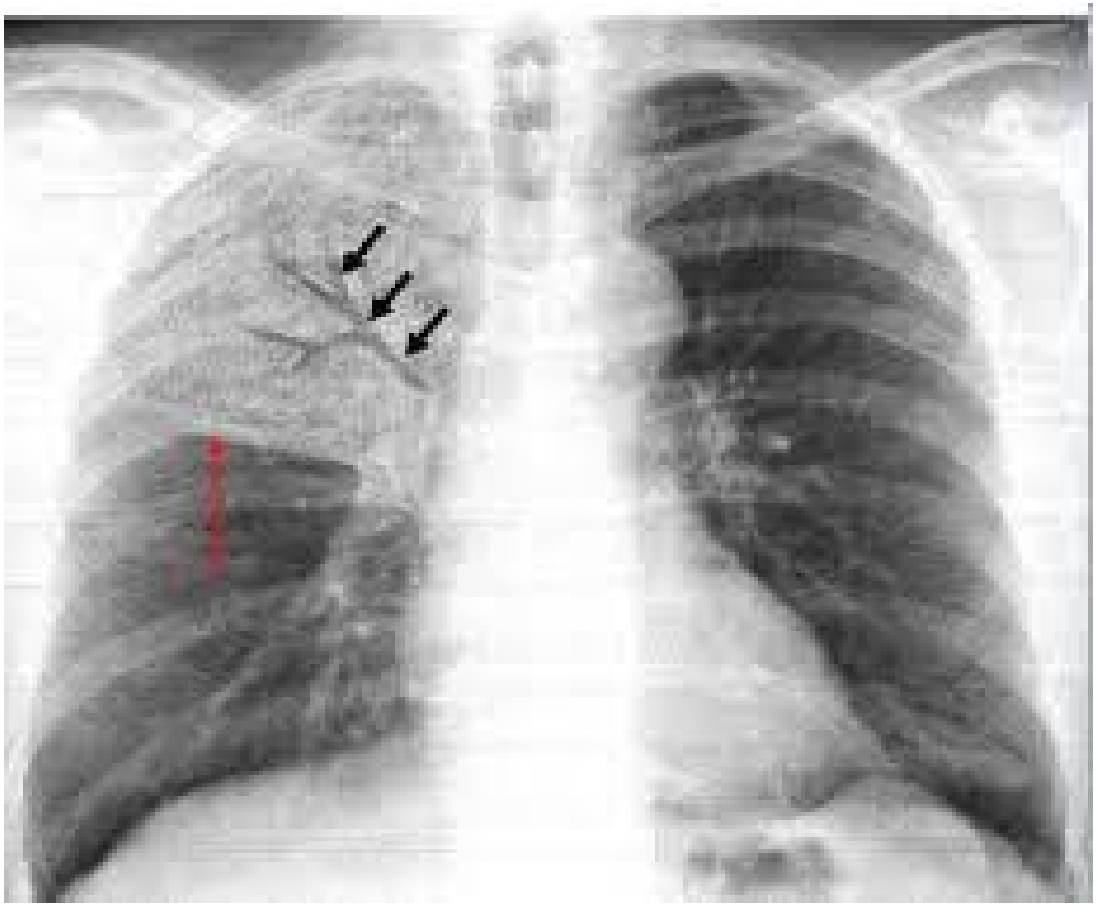
- Abolition du murmure vésiculaire
- Présence de râles crépitants dus à l'exsudation alvéolaire associés secondairement à
- Un souffle tubaire.

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

<u>Radio de thorax</u>:

- Opacité homogène plus ou moins dense,
- bien limitée,
- dont la topographie sera précisée par le cliché de profil

Syndrome de condensation pulmonaire non rétractile



http://cmed1.e-monsite.com/medias/files/le-syndrome-de-condensation-pulmonaire.pdf

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

<u>Pneumonie franche lobaire aiguë :</u>

A la phase de début

- Douleur thoracique:
  - à type de point de côté
  - Sous mamelonnaire,
- Toux sèche.
- La fièvre.

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

Pneumonie franche lobaire aiguë :

A la phase de début

l'auscultation

- des râles crépitants
  - Fins
  - secs
  - égaux entre eux
  - régulièrement espacés
  - éclatant en bouffée
  - en fin d'inspiration
- Pas de souffle tubaire

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

Pneumonie franche lobaire aiguë :

A la phase d'état :

- À partir du troisième jour
- Persistance de la toux qui ramène
- l'expectoration caractéristique : « les crachats rouillés » de Laennec :
  - crachats visqueux,
  - adhérents,
  - de couleur orangée ou ocre

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

Pneumonie franche lobaire aiguë :

A la phase d'état :

- À partir du troisième jour
- Persistance de la fièvre

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

Pneumonie franche lobaire aiguë :

A la phase d'état :

l'auscultation

- apparition d'un souffle tubaire:
  - intense
  - à tonalité élevée
  - de timbre rude
  - à prédominance inspiratoire
  - refoule les râles crépitants à la périphérie ;
- accessoirement une bronchophonie et un retentissement de la toux

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

L'infarctus pulmonaire :

- succède à une embolie pulmonaire
- apparaît 24 à 36 heures après

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

L'infarctus pulmonaire :

- L'embolie pulmonaire est suspectée chez :
  - un opéré récent,
  - une accouchée
  - un sujet alité

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

L'infarctus pulmonaire :

- L'embolie pulmonaire est suspectée devant l'apparition brutale de:
  - douleur thoracique à type de
    - point de côté
    - basi-thoracique ou para-sternale
    - polypnée
    - angoisse.

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

L'infarctus pulmonaire :

- L'embolie pulmonaire est suspectée devant l'apparition brutale de:
  - De signes généraux :
    - pouls rapide
    - élévation de la température.

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

L'infarctus pulmonaire :

- L'embolie pulmonaire est suspectée devant :
  - Des signes physiques :
    - Signes de phlébite des membres inférieurs :
      - signe de Homans (douleur provoquée à la dorsi-flexion du pied).
    - L'examen pleuro-pulmonaire est normal.

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

L'infarctus pulmonaire :

- Les signes d'infarctus pulmonaire :
  - apparaissent au bout de 24 à 36 heures.
  - Signes fonctionnels :
    - persistance de la fièvre

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

L'infarctus pulmonaire :

- Les signes d'infarctus pulmonaire :
  - Signes fonctionnels :
    - Persistance de la toux qui ramène une expectoration hémoptoïque caractéristique :
      - crachats peu nombreux,
      - épais,
      - visqueux,
      - adhérents,
      - noirâtres,
      - d'odeur alliacée

Les syndromes de condensation pulmonaire non rétractiles

L'infarctus pulmonaire :

- Les signes d'infarctus pulmonaire :
  - Signes physiques :
    - foyer de condensation pulmonaire typique avec
      - râles crépitants
      - souffle tubaire.

Les syndromes de condensation pulmonaire rétractiles

Atélectasie

Lorsque l'atélectasie intéresse un lobe

- Palpation :
  - les vibrations vocales sont soit
    - normales,
    - augmentées,
    - le plus souvent diminuées

Les syndromes de condensation pulmonaire rétractiles

Atélectasie

Lorsque l'atélectasie intéresse un lobe

- Percussion :
  - matité franche.

Les syndromes de condensation pulmonaire rétractiles

Atélectasie

Lorsque l'atélectasie intéresse un lobe

- Auscultation :
  - abolition du murmure vésiculaire.

Les syndromes de condensation pulmonaire rétractiles

Atélectasie

Lorsque l'atélectasie intéresse tout un champ pulmonaire

- Signes précédents retrouvés sur toute la hauteur de l'hémithorax

+

- L 'inspection :
  - une immobilité
  - une rétraction de l'hémithorax correspondant
  - pincement des espaces intercostaux.

Les syndromes de condensation pulmonaire rétractiles

Atélectasie

La radiographie

- Opacité dense,
- homogène
- systématisée
- rétractée

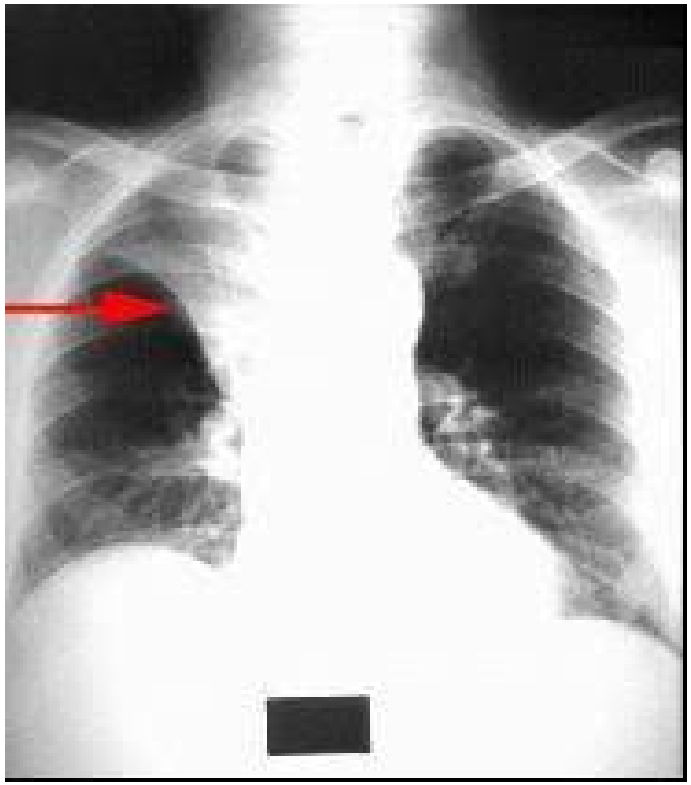
Les syndromes de condensation pulmonaire rétractiles

Atélectasie

La radiographie

- pincement des espaces intercostaux,
- attraction des organes de voisinage vers le territoire atélectasié
  - déplacement du médiastin,
  - surélévation de l'hémicoupole diaphragmatique si 1'atélectasié intéresse un hémithorax.
  - Lorsque l'atélectasie atteint un lobe pulmonaire la rétraction s'exerce sur la scissure qui apparaît arciforme à convexité dirigée vers le centre de l'opacité

Les syndromes de condensation pulmonaire rétractiles





https://www.delplanque-formation.com/Files/l_atelectasie_pulmonaire.pdf

Le syndrome cavitaire

Syndrome de condensation pulmonaire excavée

- caverne tuberculeuse
- l'abcès du poumon à la phase de foyer ouvert

Le syndrome cavitaire

Palpation :

- augmentation des vibrations vocales

Le syndrome cavitaire

Percussion

matité

Le syndrome cavitaire

Auscultation

abolition du murmure vésiculaire

Le syndrome cavitaire

Les signes propres à l'excavation

- l'auscultation +++++
  - Le souffle cavitaire :
    - intense,
    - à tonalité basse,
    - de timbre creux,
    - à prédominance inspiratoire

Le syndrome cavitaire

Les signes propres à l'excavation

- l'auscultation +++++
  - Les râles consonants :
    - râles forts,
    - humides
    - métalliques

Le syndrome cavitaire

Les signes propres à l'excavation

- l'auscultation +++++
  - L'association du souffle cavitaire et des râles consonants réalise lors de la reprise de la toux « un bruit de gargouillement » caractéristique de l'excavation de la lésion

Le syndrome cavitaire

Les signes radiologiques

- La radio de thorax montre :
  - une cavité circulaire aérique
  - entourée d'une plage de condensation dense plus ou moins étendue.
  - Cette cavité est parfois de type hydro-aérique avec
    - une opacité inférieure
    - à limite supérieure horizontale
    - surmonté d'une hyperclarté

Syndrome cavitaire

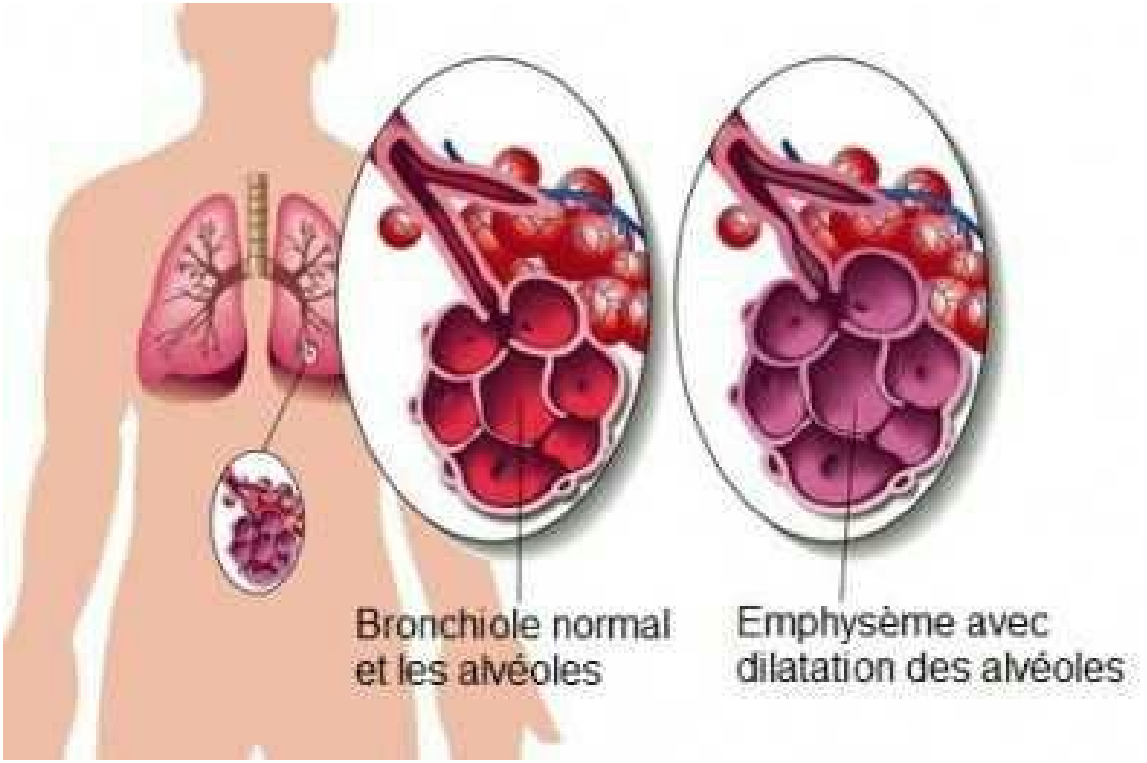


http://www.soutien-pneumologique.org/cours/4_2cavernes.pdf

L’emphysème

C'est une dilatation anormale des cavités aériennes distales au-delà des bronchioles terminales avec lésions destructrices des alvéoles. Il réalise un syndrome de distension alvéolaire

L’emphysème



https://www.santescience.fr/symptomes/emphyseme-pulmonaire/

L’emphysème

Inspection

- Modification morphologique du thorax : réalisant le thorax en tonneau
- Diminution de l'ampliation thoracique appréciée par la mesure de l'indice de Hirtz qui est très diminué, entre 2 à 4 cm (au lieu de 7 cm chez le sujet normal).
- Tirage intercostal et sus-sternal

L’emphysème

<u>Palpation</u> :

- Diminution des vibrations vocales au niveau des deux hémithorax.
- Diminution du choc de pointe

L’emphysème

<u>Percussion</u> :

Hypersonorité des deux hémithorax

L’emphysème

<u>Auscultation</u> :

- Diminution du murmure vésiculaire au niveau des deux hémithorax.
- Inversion du rythme respiratoire avec expiration prolongée.
- Diminution de l'intensité des bruits du cœur qui paraissent assourdis.

L’emphysème

La radioscopie

- Diminution de l'amplitude respiratoire
- Les coupoles diaphragmatiques sont abaissées et aplaties.
- La course diaphragmatique est diminuée, elle est de 2 à 3 cm au lieu de 8 à 10 cm chez le sujet normal

L’emphysème

<u>La radiographie</u> :

- Un élargissement des espaces intercostaux
- Une horizontalisation des côtes.
- Une hyperclarté du parenchyme pulmonaire



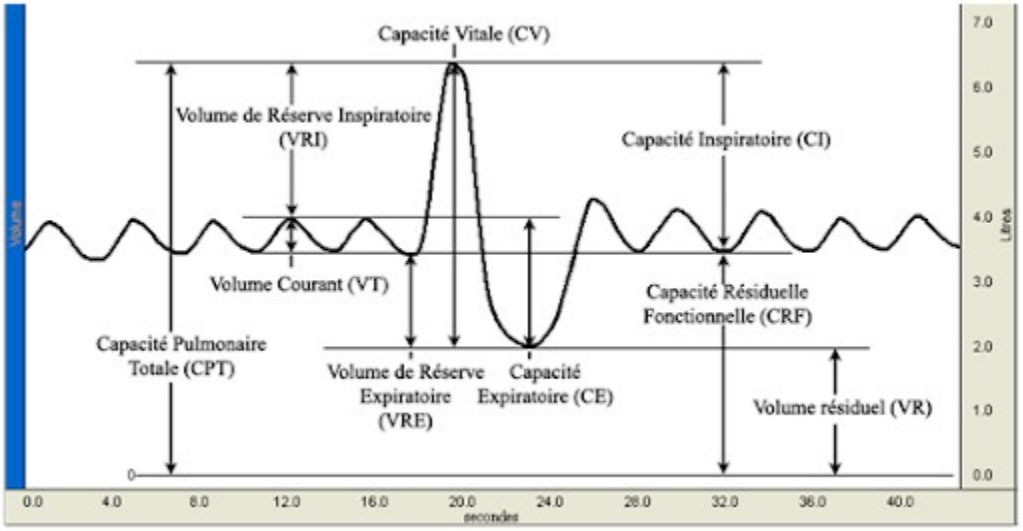
https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.2017.03078

L’emphysème

L'exploration fonctionnelle respiratoire

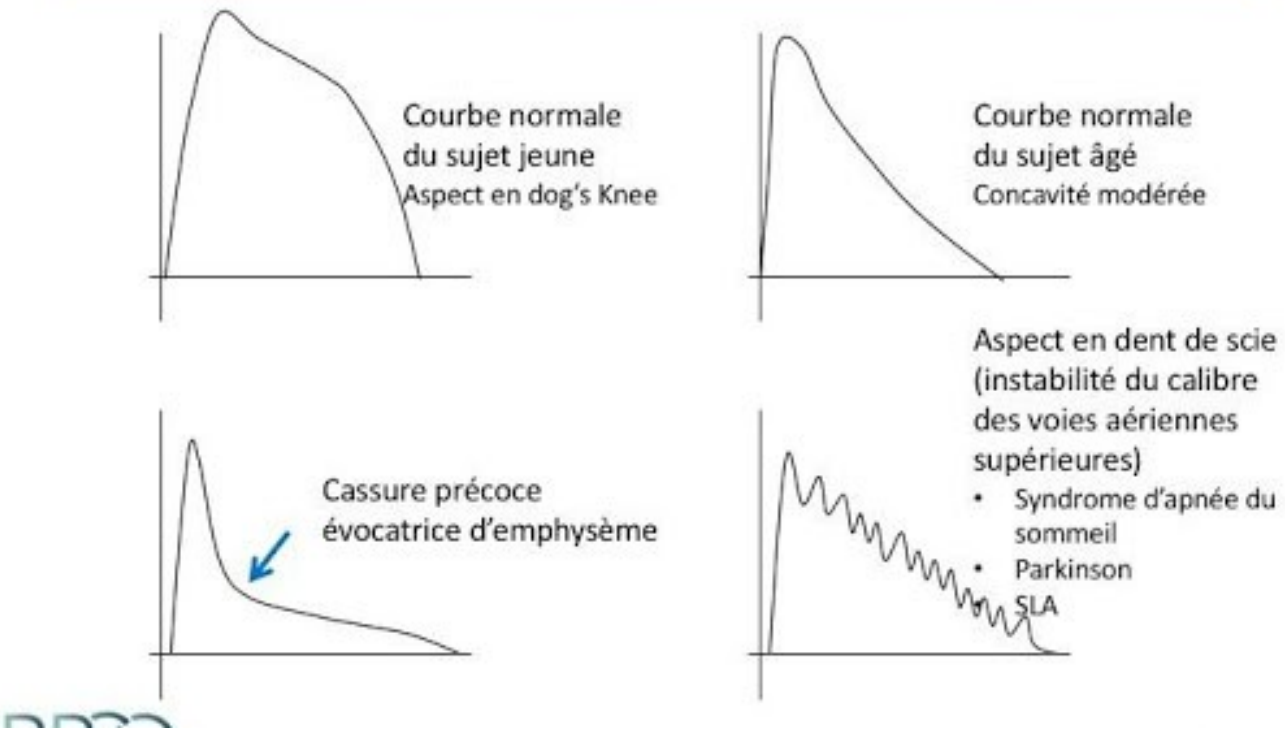
- un syndrome de type obstructif associant
  - Une diminution de la capacité vitale par diminution du volume de réserve expiratoire.
  - Une diminution importante du VEMS et diminution de l'indice de Tiffeneau.
  - La mesure des gaz du sang va objectiver
    - une hypoxie (diminution de la p O2) avec diminution de la saturation en oxygène de l'hémoglobine
    - Souvent une hypercapnie (augmentation de la p CO2).

EFR



http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/kharfi/partie2chap3.html

Débits



http://formathon.fr/Formathon/425/efr-au-cabinet-du-medecin-generaliste

LES SYNDROMES BRONCHIQUES

Introduction

- La crise d'asthme,
- La bronchite chronique
- La dilatation des bronches.

La crise d'asthme

- une broncho-constriction soudaine mais transitoire.
- Signe caractéristique : râles sibilants ++++

La crise d'asthme

- crise de dyspnée paroxystique
- survenant au repos
- Évoluant en deux phases.
  - La phase sèche
  - La phase catarrhale

La crise d'asthme

La phase sèche :

- le début est brutal,
- le plus souvent nocturne,
- bradypnée expiratoire avec orthopnée ,
- la fréquence respiratoire est diminuée entre 10 et 12 mouvements par minute,
- l'inspiration est brève,
- l'expiration est
  - difficile,
  - prolongée,
  - volontaire
  - bruyante;
- le malade ne peut supporter la position de décubitus

La crise d'asthme

<u>La phase sèche :</u>

- A l'inspection :
  - Une diminution de l'ampliation thoracique
  - thorax distendu, bloqué en inspiration forcée
  - horizontalisation des côtes

La crise d'asthme

<u>La phase sèche :</u>

- A la percussion :
  - une hypersonorité des deux hémithorax

La crise d'asthme

La phase sèche :

- A l'auscultation :
  - une inversion du rythme respiratoire, l'expiration devient plus longue que l'inspiration,
  - une diminution du murmure vésiculaire
  - la présence de râles sibilants qui réalisent des sifflements expiratoires aigus et prolongés

La crise d'asthme

<u>La phase catarrhale</u> :

Au bout de 2 à 3 heures apparaît

- Une hypersécrétion bronchique qui se manifeste par
  - Une toux productive: avec
    - expectoration muqueuse
    - crachats peu nombreux
    - peu abondants,
    - blanc grisâtre
    - translucides,
    - visqueux, .

    } « crachats perlés » de Laennec
    - Plus rarement l'expectoration est abondante de type séro-muqueux.

La crise d'asthme

<u>La phase catarrhale</u> :

Au bout de 2 à 3 heures apparaît

- Une hypersécrétion bronchique qui se manifeste par
  - L'apparition de râles ronflants qui viennent s'ajouter aux râles sibilants réalisant un « bruit de pigeonnier

La crise d'asthme

Après la crise

Dans les heures qui suivent et le lendemain,

- l'auscultation :
  - râles sibilants qui permettent de poser le diagnostic d'asthme si on n'a pas assisté à la crise

La crise d'asthme

La radio du thorax :

- montre un élargissement des espaces intercostaux
- horizontalisation des côtes
- une hyperclarté du parenchyme pulmonaire

La crise d'asthme

L'exploration fonctionnelle respiratoire

- fait le diagnostic d'asthme en dehors de la crise,
- elle va montrer une diminution du VEMS provoquée par l'acétylcholine.
- Un syndrome obstructif réversible ++++

La bronchite chronique

- Est caractérisée par une hypersécrétion muqueuse au niveau des bronches,
- elle est souvent compliquée d'infection d'où l'expectoration muco-purulente abondante à type de bronchorrhée souvent retrouvée.

La bronchite chronique

- Elle est définie par l'existence chez un malade
- d'une **toux productive chronique** ou **récidivante**
- pendant **au moins 3 mois** non forcément consécutifs dans l'année
- pendant au moins 2 années successives,
- après avoir éliminé toute autre maladie broncho-pulmonaire en particulier la dilatation des bronches et la tuberculose pulmonaire.

La bronchite chronique

- les signes fonctionnels :
  - Toux productive.
  - Expectoration :
    - muqueuse ou muco-purulente
    - souvent abondante à type de bronchorrhée.

La bronchite chronique

- L'examen clinique est pauvre,
- il peut mettre en évidence des râles bronchiques surtout à type de râles ronflants au moment des poussées infectieuses.

La dilatation des bronches

- Est définie comme une dilatation permanente du calibre de plusieurs bronches de moyen calibre.

La dilatation des bronches

- signes fonctionnels :
  - Toux quotidienne et matinale.
  - Expectoration caractéristique muco-purulente abondante réalisant la bronchorrhée sédimentant en quatre couches.

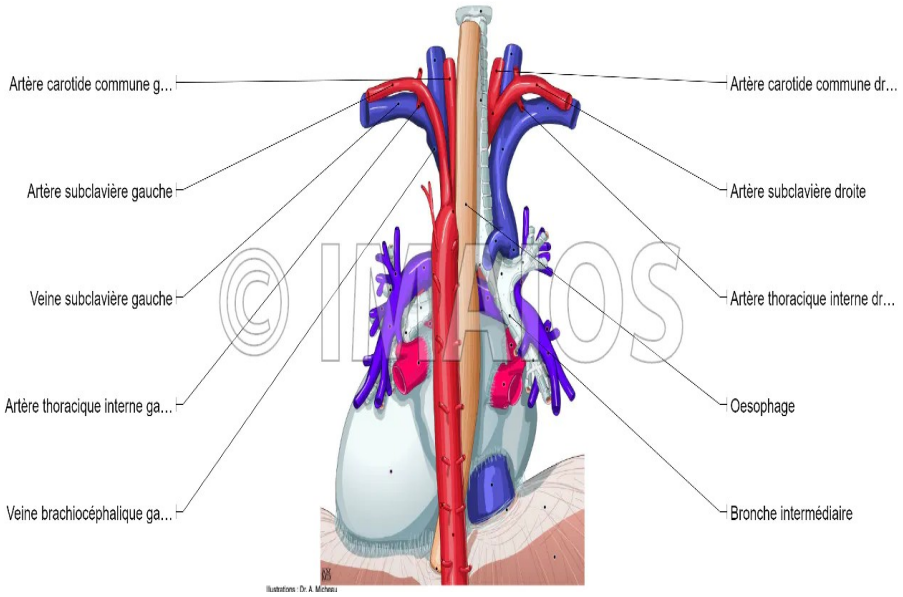
La dilatation des bronches

- Confirmation : TDM thoracique

SYNDROMES MÉDIASTINAUX

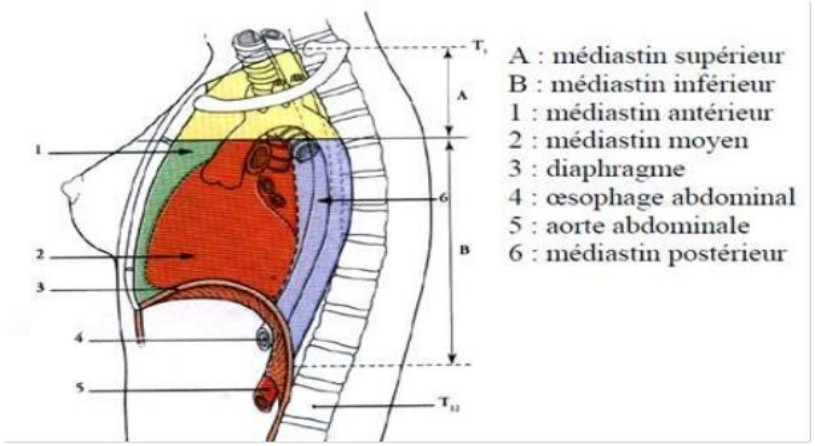
Introduction

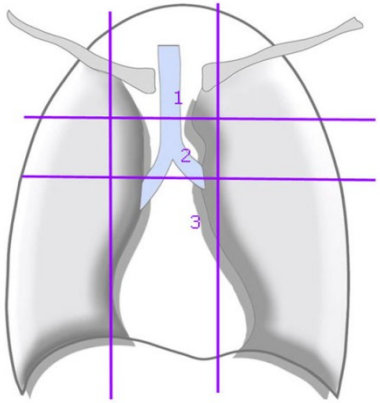
- Le médiastin est occupé par de nombreux organes, vaisseaux et nerfs

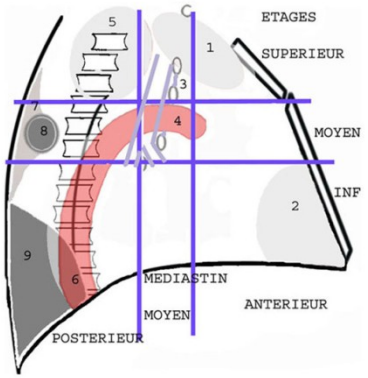


Anatomie de médiastin

Division de médiastin







Syndrome Médiastinal

- La compression ou l'irritation de l'un ou plusieurs d'entre eux réalise une association de signes cliniques dépendante de la topographie

Atteinte du nerf phrénique

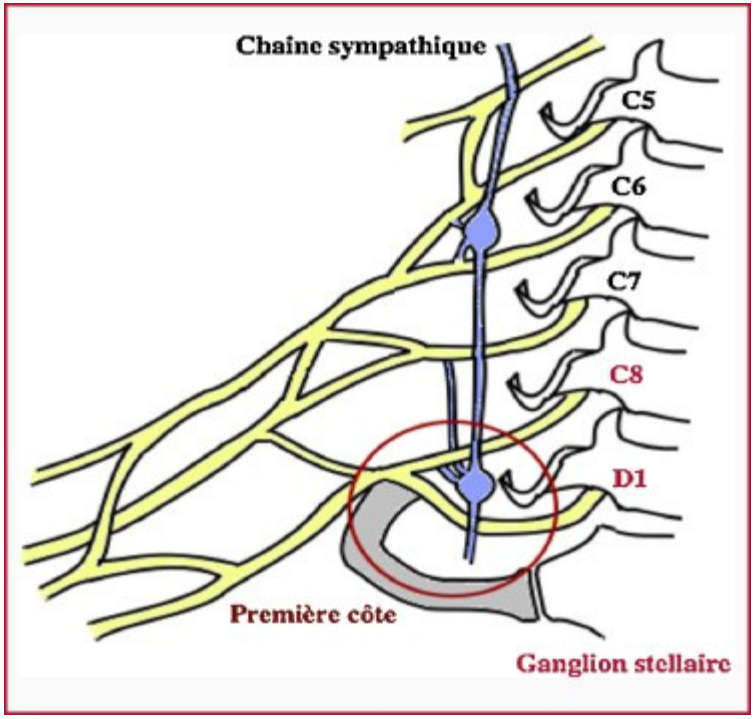
- Son irritation = un hoquet,
- Une compression = une paralysie phrénique
  - une dyspnée
  - une asymétrie des mouvements thoraciques,
  - ascension paradoxale d'un hémi-diaphragme en radioscopie (l'hémidiaphragme paralysé remonte à l'inspiration profonde).

Atteinte du nerf récurrent gauche

- Provoque une paralysie de la corde vocale avec dysphonie.
- Le nerf récurrent droit n’est pas atteint au cours des syndromes médiastinaux.

Atteinte du plexus brachial

- Une douleur descendant sur le bord interne du bras et le 5ème doigt, associée à des troubles sensitifs dans le même territoire
  - cancer du sommet,
  - syndrome de Pancoast-Tobias



Le syndrome de Pancoast-Tobias : une entité à plusieurs visages, à propos de 95 cas, Volume 18, Issue 3,2017, Pages 146-151, ISSN 1624-5687, (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624568717300732)

Atteinte du plexus brachial

<u>syndrome de Pancoast-Tobias</u>

- Tumeur de l'apex pulmonaire
- Lyse osseuse
- Syndrome de Claude Bernard - Horner



I. Rida-Chafi. Syndrome de Pancoast-Tobias. Ann. Fr. Med. Urgence (2013) 3:317

Atteinte du sympatique dorsal ou cervical

- syndrome de Claude Bernard Horner, associant
  - Myosis,
  - Ptosis, Chute de la paupière supérieure
  - Énophtalmie.
- L'atteinte du sympathique dorsal peut donner
  - Une hypersudation,
  - Des phénomènes vaso-moteurs au niveau d'un hémithorax



https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article1629

Le syndrome de la veine cave supérieure

- une cyanose localisée
  - aux mains
  - au visage
    - nez,
    - lèvres,
    - pommettes,
    - oreilles,
    - ongles,
    - Doigts
  - Accentuée par la toux et l'effort



Le syndrome de la veine cave supérieure

- un œdème en pélerine
  - la face
  - la base du cou
  - la partie antéro-supérieure du thorax et des brasrespectant le dos,
- effaçant le relief claviculaire,
- rénitent ne prenant pas le godet.
- Il est plus marqué le matin et en position couchée

Le syndrome de la veine cave supérieure

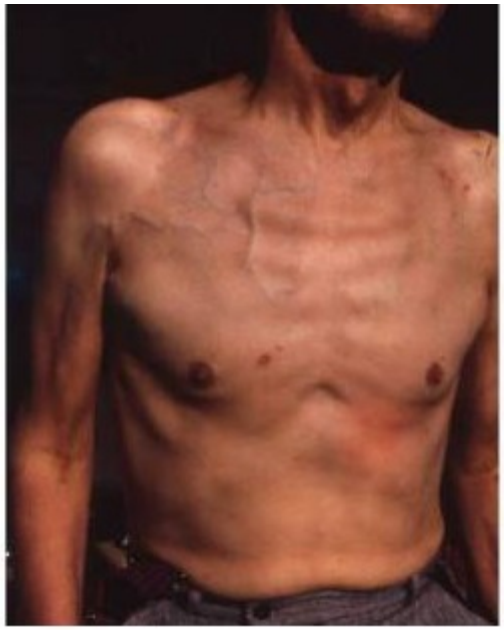
- une turgescence veineuse
  - des veines jugulaires,
  - des veines sublinguales,
  - Des veines des fosses nasales,
  - Des veines rétiniennes (visibles au fond d'œil).

    Elle peut entrainer
    - épistaxis
    - hémoptysies.

s'intensifient en position couchée ou par inclinaison du tronc en avant : signe de la bèche de Sorlano

Le syndrome de la veine cave supérieure

- une circulation collatérale débutant
  - sur les faces antérieures et latérales du thorax.
  - Elle prédomine dans les 2/3 supérieurs du thorax et peut prendre un développement considérable.



Le syndrome de la veine cave supérieure

- Une somnolence et des céphalées de fin de nuit.